우연히 발견된 담관·췌관 확장: 추가 검사와 의뢰 판단

담관과 췌관을 구분하고, 이전 영상과 변화 여부를 비교합니다.

CT에 종괴가 없어도 확장의 성격을 구분

우연히 발견된 CBD 또는 주췌관 확장

담관(CBD)
고령·담낭절제 후
증상·간기능·영상 이상 없음
추가 추적이 필요 없는 경우 있음

주췌관(MPD)
원인 불명의 명확한 확장
새로 발생·진행하는 확장
MRCP 또는 EUS 평가 고려

담관·췌관 판단과 추가검사 선택은 연자 Q&A 의견입니다.

! 적극 평가로 연결하는 영상·임상 단서

영상 단서 · 연자 Q&A 의견	임상 단서 · 강의
주췌관 ≥5 mm의 뚜렷한 확장	통증 양상 변화·급격한 악화
갑작스러운 관 단절(abrupt cutoff)	설명되지 않는 체중감소·새 당뇨·혈당 악화
원위부 췌장 위축(distal atrophy)	황달·ALP/bilirubin 상승
담관도 함께 확장된 double-duct sign	국소 췌관 협착 + 상류부 확장

검사·의뢰 선택

상황	다음 단계
CT 종괴 없음 + 위험 단서	작은 췌장암·IPMN 배제: MRCP/EUS 고려(연자 Q&A 의견).
암 의심 소견이 있는 경우	EUS ± 조직채취, 단면영상 재판독·비교; 필요시 ERCP brush/biopsy 또는 수술 평가. CA19-9 단독 선별에 의존하지 않음.
만성췌장염 고의심 + 애매한 영상	기준 영상 후 6–12개월 재평가 고려. 외분비기능·영양·당뇨 평가 병행.

광교바른내과 · 의료진 진료 참고
아산 28회 연수강좌 — 만성췌장염: 진단의 핵심과 치료의 실제(오동욱)
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호 · 031-893-4560
평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토 08:30~13:30 · 일·공휴일 휴진

자료 다시 보기
QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/gi/asan28-incidental-duct-dilatation/